

Oclusión patológica: causas directas e indirectas

Tema 5 · Oclusión patológica

Definición

Es aquella oclusión que **supera la capacidad de adaptación** del sistema estomatognático y produce daño en alguno de sus componentes: dientes, periodonto, músculos o articulación.

Ojo con esto: no toda oclusión ideal es sana ni toda maloclusión es patológica. Lo que define lo patológico no es la forma, es el **daño**. Un paciente con apiñamiento y sin signos de daño no tiene oclusión patológica; uno con oclusión aparentemente normal pero con desgaste severo y dolor muscular, sí.

No son lo mismo

- **Maloclusión:** una desviación de la relación dentaria considerada normal. Es un criterio **morfológico**.
- **Oclusión patológica:** una oclusión que está causando daño. Es un criterio **funcional y biológico**.

Puede haber maloclusión sin patología y patología sin maloclusión evidente. Por eso el diagnóstico no se hace solo mirando los modelos.

La clave está en la adaptación

El sistema estomatognático tolera bastante. Ante una fuerza anormal puede adaptarse con remodelado óseo, desgaste fisiológico o cambios musculares, y seguir funcionando sin síntomas.

La patología aparece cuando la demanda **supera** esa capacidad. Esa capacidad varía entre personas: por eso dos pacientes con la misma interferencia pueden tener uno un cuadro doloroso y el otro nada.

Causas directas

Son las que actúan **sobre la oclusión misma** y alteran el contacto entre los dientes:

- Interferencias oclusales en céntrica, trabajo o balance
- Contactos prematuros
- Pérdida dentaria no rehabilitada, con migración y extrusión
- Restauraciones en sobreoclusión o con anatomía incorrecta
- Desgaste dentario que altera las guías
- Tratamientos protésicos u ortodóncicos mal terminados
- Fracturas dentarias o radiculares

Causas indirectas

No alteran el contacto dentario, pero **modifican la carga** que ese contacto recibe:

- Hábitos parafuncionales: bruxismo y apretamiento
- Estrés y alteraciones del sueño
- Trastornos de la ATM previos
- Alteraciones posturales y respiración bucal
- Enfermedad periodontal, que reduce el soporte
- Deglución atípica y otros hábitos linguales
- Factores sistémicos como artritis o enfermedades del colágeno

Suelen ser las más difíciles de controlar, porque no se resuelven con ajuste oclusal.

Qué buscar en la exploración

- **Dentario:** facetas de desgaste, abfracciones, fracturas de cúspides, movilidad
- **Periodontal:** ensanchamiento del ligamento en radiografía, migración dentaria, recesiones
- **Muscular:** dolor a la palpación, hipertrofia maseterina, fatiga al masticar
- **Articular:** ruidos, limitación de apertura, desviación al abrir, dolor preauricular

Ningún signo aislado hace el diagnóstico. Lo que lo hace es el **patrón**.

Trauma oclusal

Es la lesión del periodonto por fuerzas oclusales excesivas. Se divide en dos:

- **Trauma primario:** fuerza **excesiva** sobre un periodonto **sano**. Ejemplo típico: una restauración alta.
- **Trauma secundario:** fuerza **normal** sobre un periodonto **disminuido** por enfermedad periodontal previa.

La distinción importa porque el tratamiento cambia: en el primario ajustas la oclusión; en el secundario primero tienes que tratar la periodontitis.

Secuencia de manejo

1. **Diagnóstico** completo: historia, exploración, modelos montados, análisis oclusal
2. **Control de la causa indirecta** cuando existe: manejo del bruxismo, del estrés, de la periodontitis
3. **Terapia reversible** primero: férula oclusal, educación, fisioterapia
4. **Terapia irreversible** solo después y con indicación clara: ajuste oclusal, rehabilitación, ortodoncia

La regla de oro es empezar por lo reversible. Si desgastas esmalte sin diagnóstico, no hay marcha atrás.

Este material también está disponible en la plataforma, con ejercicios de autoevaluación por niveles y el asistente académico. **dentipedia.dentilike.com.mx**